ANEMIE DE L'ENFANT

Pr. N. Benali Khoudja

Année Universitaire 2025 - 2026

SAMEDI PEDAGOGIQUE 20/06/2026

Observation

- Yacine, garçon de 10 mois, est amené en consultation pour pâleur progressive, irritabilité et retard de prise pondérale.

Antécédents

- Grossesse et accouchement sans particularité.
- Pas de consanguinité connue.
- Vaccinations à jour.
- **Examen clinique**
- Poids : inférieur au 3e percentile.
- Pâleur cutanéo-muqueuse importante.
- Ictère discret.
- Hépatosplénomégalie (foie +3 cm, rate +5 cm).
- Souffle systolique fonctionnel.

Bilan biologique

Hémoglobine : 5,8 g/dL ,VGM : 58 fL ,TCMH : 18 pg
GB=15000(PNN10000, lymp 3500)
PLT= 380000/mm3
Réticulocytes : 87200 elt/mm3
Ferritine : 350µg/l , fer serique
Frottis sanguin : anisopoïkilocytose, cellules cibles, érythroblastes circulants.

Électrophorèse de l'hémoglobine

HbF : 92 %
HbA : absente
HbA2 : 8 %

Question 1:

- Le tableau clinique est évocateur d'un(e):

  A/ Hémopathie maligne.

  B/ Syndrome d'activation macrophagique.

  C/ Maladie de surcharge.

  D/Hémolyse chronique.

  E/Leishmaniose viscérale.

Question 1:

- Le tableau clinique est évocateur d'un(e):

  A/ Hémopathie maligne.

  B/ Syndrome d'activation macrophagique.

  C/ Maladie de surcharge.

  D/Hémolyse chronique.

  E/Leishmaniose viscérale.

Question 2

- Quel est le bilan à effectuer chez votre patient?

  1/ TDA / RAI.

  2/Groupage sanguin avec phénotype.

  3/FNS + Frottis sanguin + taux de réticulocytes.

  4/ Fer sérique, Ferrtinémie, CRP.

  5/Bilirubine , Haptoglobine.

A/ 1+2+3 B/1+2+3+4 C/1+2+3+4+5 D/1+3+4+5 E/2+3+5

Question 2

- Quel est le bilan à effectuer chez votre patient?

  1/ TDA / RAI.

  2/Groupage sanguin avec phénotype.

  3/FNS + Frottis sanguin + taux de réticulocytes.

  4/ Fer sérique, Ferrtinémie, CRP.

  5/Bilirubine , Haptoglobine.

A/ 1+2+3 B/1+2+3+4 **C/1+2+3+4+5** D/1+3+4+5 E/2+3+5

Question 3

- Quel est votre diagnostic étiologique selon les données du patient?

A/ Béta thalassémie homozygote.

B/ Drépanocytose hétérozygote.

C/ Béta thalassémie hétérozygote.

D/ Anémie hémolytique autoimmune.

E/ Syndrome hémolytique et urémique.

Question 3

- Quel est votre diagnostic étiologique selon les données du patient?

A/ Béta thalassémie homozygote.

B/ Drépanocytose hétérozygote.

C/ Béta thalassémie hétérozygote.

D/ Anémie hémolytique autoimmune.

E/ Syndrome hémolytique et urémique.

Question 4

- L'anomalie biologique la plus évocatrice d'une β-thalassémie majeure est :

A. Ferritine élevée
B. HbF très augmentée
C. VGM élevé
D. Hyperplaquettose
E. Taux de réticulocyte bas.

Question 4

- L'anomalie biologique la plus évocatrice d'une β-thalassémie majeure est :

A. Ferritine élevée
B. HbF très augmentée
C. VGM élevé
D. Hyperplaquettose
E. Taux de réticulocyte bas.

Question 5

- Donner le mécanisme physiopathologique de la béta thalassémie:

  A/ Anémie hémolytique.

  B/Insuffisance médullaire.

  C/Défaut d'intégration du fer.

  D/ Erythropoïèse inefficace.

  E/ Destruction des globules rouges par des auto anticorps.

Question 5

- Donner le mécanisme physiopathologique de la béta thalassémie:

A/ Anémie hémolytique.

B/Insuffisance médullaire.

C/Défaut d’intégration du fer.

D/ Erythropoïèse inefficace.

E/ Destruction des globules rouges par des auto anticorps.

Question 6

- La béta thalassémie intermédiaire non compliquée est reconnue par :

  1/ phénotype peu sévère.

  2/Besoins transfusionnels élévés.

  3/ Un génotype β +.

  4/ Un génotype β 0.

  5/ Besoins transfusionnels modérés.

A/1+2+3 B/1+3+5 C/1+2+4 D/2+4 E/ 2+5

Question 6

- La béta thalassémie intermédiaire non compliquée est reconnue par :

  1/ phénotype peu sévère.

  2/Besoins transfusionnels élévés.

  3/ Un génotype β +.

  4/ Un génotype β 0.

  5/ Besoins transfusionnels modérés.

A/1+2+3 **B/1+3+5** C/1+2+4 D/2+4 E/ 2+5

Question 7

- Le mode de transmission de la β-thalassémie majeure est :

A. Liée à l'X
B. Dominante autosomique
C. Récessive autosomique
D. Mitochondriale
E. Maladie non génétique

Question 7

- Le mode de transmission de la β-thalassémie majeure est :

A. Liée à l'X
B. Dominante autosomique
C. Récessive autosomique
D. Mitochondriale
E. Maladie non génétique

Question 8

- L'âge habituel de révélation est :
- A. Naissance
  B. 1 à 2 mois
  C. Après 6 mois
  D. A 2 ans
  E. Après 10 ans

Question 8

- L'âge habituel de révélation est :
- A. Naissance
  B. 1 à 2 mois
  C. Au alentours de 6 mois
  D. A 2 ans
  E. Après 10 ans

Question 9

- Quel examen confirme le diagnostic ?

A. Myélogramme
B. Électrophorèse de l'hémoglobine
C. Test de Coombs
D. CRP
E. Ferritinémie

Question 9

- Quel examen confirme le diagnostic ?

A. Myélogramme
B. Électrophorèse de l'hémoglobine
C. Test de Coombs
D. CRP
E. Ferritinémie

Question 10

- La complication majeure des transfusions répétées est :

A. Hypocalcémie
B. Alloimmunisation
C. Hypoglycémie
D. Hyperuricémie
E. Hémochromatose secondaire

Question 10

- La complication majeure des transfusions répétées est :

A. Hypocalcémie
B. Alloimmunisation
C. Hypoglycémie
D. Hyperuricémie
E. Hémochromatose secondaire

Question 11

- Le traitement curatif actuellement reconnu est :

A. Corticothérapie
B. Splénectomie
C. Greffe de cellules souches hématopoïétiques
D. Hydroxy urée.
E. Programme transfusionnel intensif.

Question 11

- Le traitement curatif actuellement reconnu est :

A. Corticothérapie
B. Splénectomie
C. Greffe de cellules souches hématopoïétiques
D. Hydroxy urée.
E. Programme transfusionnel intensif.

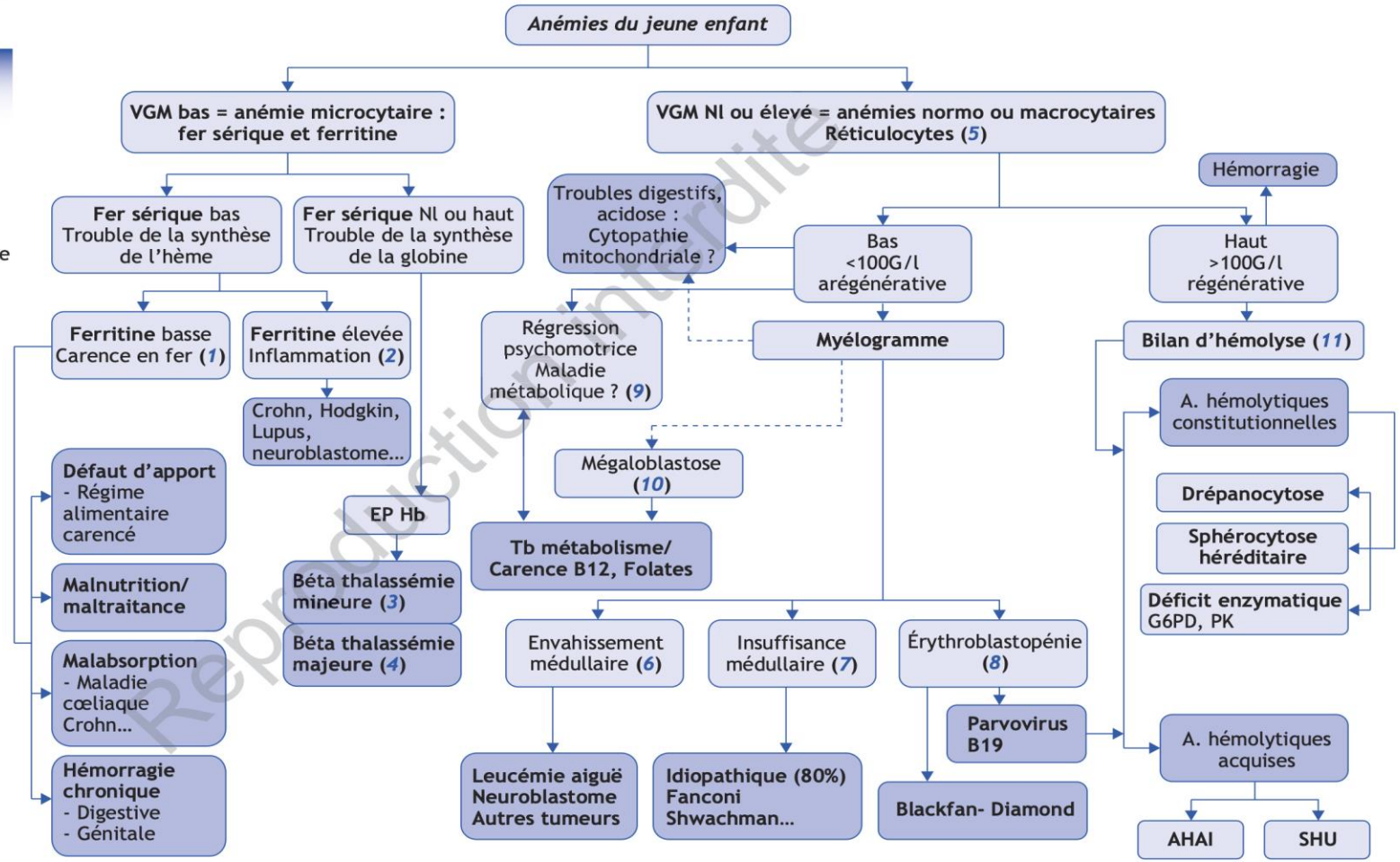
Anémies du jeune enfant

C. Pondarré

Université Paris-Est Créteil, service de pédiatrie, centre hospitalier intercommunal de Créteil, 40, avenue de Verdun, 94000 Créteil, France

Abréviations

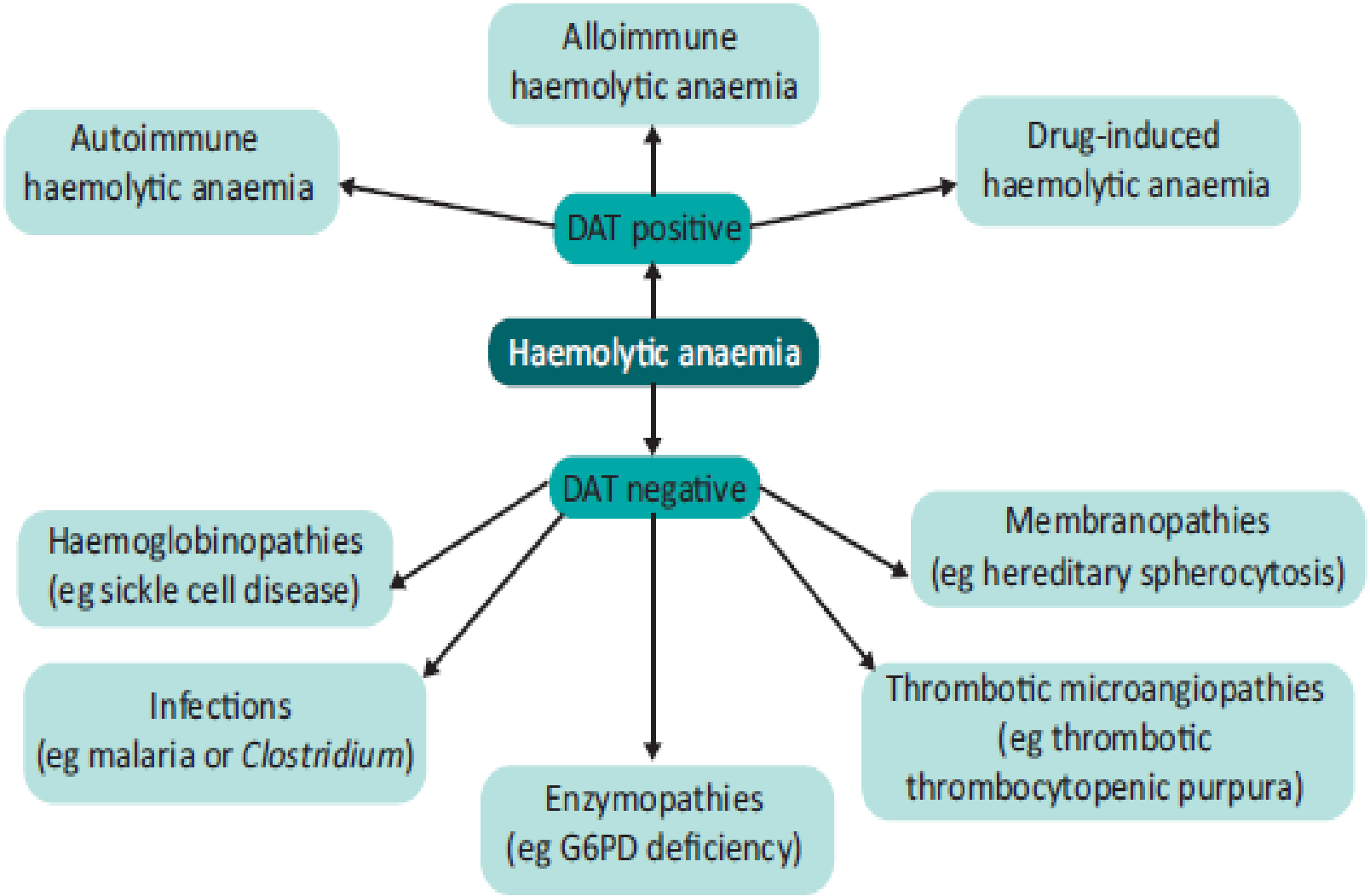
A : Anémie
AEG : Altération état général
AHAI : Anémie hémolytique autoimmune
Bili : Bilirubine
Dl : Douleur
EP : Électrophorèse
G6PD : Glucose 6-phosphate deshydrogénase
hapto : Haptoglobine
Hb : Hémoglobine
PK : Pyruvate kinase
Sd : Syndrome
SHU : Sd hémolytique et urémique
Tb : Troubles



Reproduction interdite

IV/ CLASSIFICATION

- **HEMOLYSE**
- ↙∞↘
- **CORPUSCULAIRE :↘ vie GR patient** **EXTRACORPUSCULAIRE :↘ vie GR patient**
- **↘ vie GR transfusés**
- ↙ ↘ ↙ ↙ ↓ ↘ ↘
- **Héréditaires :** **Aquises :** **immunologiques** **mécanq** **hypersplén** **toxiq** **infection**
- ***anomalies membrane :** ***hémoglobinurie** ***incompatibilié** ***SHU** **séquestrat°** **plomb** **perfringen**
- **Sphérocytose** **paroxystique nocturne** **materno-fœtal** ***CIVD** **Mdcmt Paludism**
- **Ellipsocytose** **(HPN)** ***AHAI** *** prothèse** **(ATB)**
- **Stomatocytose** ***alloimmunisat°** ***CEC** **(AINS)**
- ***anomalie Hb :β thalassémies**
- **Hémoglobinopathies**
- **(Drépanocytose)**
- **Méthémoglobinopathies.**
- ***Déficit enzymatique : G6PD, pyruvate kinase , Glutathion réductase**


Haemolytic anaemia
DAT positive
DAT negative
Alloimmune haemolytic anaemia
Autoimmune haemolytic anaemia
Drug-induced haemolytic anaemia
Haemoglobinopathies (eg sickle cell disease)
Membranopathies (eg hereditary spherocytosis)
Infections (eg malaria or *Clostridium*)
Thrombotic microangiopathies (eg thrombotic thrombocytopenic purpura)
Enzymopathies (eg G6PD deficiency)